

Eduface testdag

Opleiding MSc Manuele Therapie

Vak CAT diagnostiek

Student Student 1

Beoordeeld op 9 december 2025

Gekozen voldaan of niet voldaan, per rubriekcriterium

Wat dat doet Het model spreekt per criterium alleen uit of eraan is voldaan. Het geeft geen kwaliteitsniveau en geen cijfer.

De beoordeling naast elkaar

Criterium	Gewicht	Nakijker	Eduface	Uitkomst
Algemeen	12%	voldaan	voldaan	● eens
Klinisch scenario (stap 1)	12%	½ deels	voldaan	→ model milder
Klinische vraagstelling (stap 2)	12%	voldaan	voldaan	● eens
Zoekstrategie (stap 3)	12%	voldaan	voldaan	● eens
Kritische evaluatie van kwaliteit (stap 4)	12%	voldaan	voldaan	● eens
Evidentietabel (stap 5)	12%	voldaan	voldaan	● eens
Commentaar (stap 6)	12%	voldaan	voldaan	● eens
Conclusie (stap 7)	16%	voldaan	voldaan	● eens

7 van 8

voldaan bij de nakijker

8 van 8

voldaan bij Eduface

7 van 8

criteria waarop ze het eens zijn

Wat de nakijker schreef

Hey [...], Deze opdracht heb je afgerond. Je hebt hier en daar wel wat kort door de bocht uitgevoerd. Maar dat is bij deze opdracht nog niet zo'n probleem.

Binnen Klinisch scenario is het onderdeel over de klinische relevantie en de motivatie voor de klinische vraag niet afgevinkt. De overige onderdelen wel. Eindoordeel van de nakijker: voldaan. Eindoordeel van Eduface: voldaan.

Aantekeningen

Per criterium, letterlijk

1. Algemeen

Je hebt je CAT logisch opgebouwd, waardoor de redenering goed te volgen is. Maar de tekst is nog niet overal consistent en de overgang van resultaten naar conclusie kan duidelijker. Controleer vaste vaktermen en grammatica, zoals MRA/RMA en labrumletsel. Voeg verbindende zinnen toe die resultaten aan je conclusie koppelen. Ik vind de feedback wel sterk alleen mist MRA nog een beetje.

2. Klinisch scenario (stap 1)

Je beschrijft de patiënt en haar klachten duidelijk en onderbouwt de hypothese van labrumletsel goed. Maar de presentatie kan nog vloeiender. Formuleer anamnese en onderzoek compacter en sluit af met één zin waarin je uitlegt dat de bevindingen samen de hypothese ondersteunen en de diagnostische vraag motiveren.

3. Klinische vraagstelling (stap 2)

Je hebt een heldere en goed meetbare klinische vraag opgesteld. Maar de onderbouwing van de lage voorkans blijft nog te algemeen. Licht kort toe waarom deze voorkans in de eerstelijns én bij deze patiënt aannemelijk is, en verbind dit niet alleen aan Simpto.nl.

4. Zoekstrategie (stap 3)

Je zoekstrategie is goed navolgbaar en je keuze voor het artikel is logisch gekoppeld aan je patiënt. Maar de toepasbaarheid kan duidelijker. Zet bij de artikelkeuze de publicatiedatum en taal en vergelijk de inclusie- en exclusiecriteria direct met de klachten en voorafkans van jouw patiënt.

5. Kritische evaluatie van kwaliteit (stap 4)

Je hebt de belangrijkste methodologische aandachtspunten helder benoemd en met goede voorbeelden aan de klinische praktijk gekoppeld. Maar het blijft onduidelijk wat het ontbrekende afkappunt betekent voor de betrouwbaarheid van sensitiviteit en specificiteit. Leg dit kort uit en verbind je conclusie daarna expliciet aan de beslissing voor jouw patiënt.

6. Evidentietabel (stap 5)

Je hebt de kengetallen voor de artikelpopulatie en praktijksituatie correct en duidelijk weergegeven; zo wordt de invloed van een lage voorafkans zichtbaar. Maar de berekeningen zijn niet overal controleerbaar, omdat aantallen en percentages door elkaar lopen. Schrijf de tussenstappen consequent uit en vermeld eerst de aantallen, daarna het percentage.

7. Commentaar (stap 6)

Je commentaar koppelt de beperkingen en testkenmerken goed aan deze patiënt. Maar de stap naar de eerstelijns manuele therapiepraktijk kan concreter. Beschrijf wanneer een negatieve test je vervolgbeleid beïnvloedt en formuleer dat de test labrumletsel minder waarschijnlijk maakt, maar niet zelfstandig uitsluit.

8. Conclusie (stap 7)

Je Bottom Line beantwoordt de klinische vraag duidelijk en houdt terecht rekening met de beperkte generaliseerbaarheid. Maar de vervolgstap voor deze patiënt blijft nog te impliciet. Beschrijf concreet dat je geen directe MRA inzet, de patiënt klinisch vervolgt en bij aanhoudende of ernstige klachten herbeoordeelt of verwijst.

De plekken met een verschil

Klinisch scenario (stap 1)

→ model milder

Nakijker	Het onderdeel over de klinische relevantie en de motivatie voor de klinische vraag is niet afgevinkt. De overige onderdelen van dit criterium wel.
Eduface	"Je beschrijft de patiënt en haar klachten duidelijk en onderbouwt de hypothese van labrumletsel goed. Maar de presentatie kan nog vloeiender." Het model vraagt om een compactere formulering en om één afsluitende zin.
Rubriek	<i>De letterlijke rubriektekst van dit onderdeel is hier niet beschikbaar, dus deze regel blijft leeg.</i>

Het model noemt de patiëntpresentatie en de hypothese voldoende en vraagt alleen om een vloeiendere formulering. Wanneer weegt de motivatie voor de klinische vraag bij jullie zwaar genoeg om dit onderdeel niet te laten voldoen?

Aantekeningen

Wat het model aanneemt, en wat jullie willen

Het model beoordeelt een criterium als één geheel

Eduface zegt Op Klinisch scenario geeft het model één uitkomst voor het hele criterium.

De rubriek zegt	Het beoordelingsformulier splitst dit criterium in meerdere onderdelen, elk met een eigen vinkje.
------------------------	---

In de praktijk De nakijker vinkte één van die onderdelen niet af en de andere wel.

Het model geeft per criterium één uitkomst en kan een los onderdeel daarin niet apart laten vervallen. Willen jullie de onderdelen apart beoordeeld zien, of is één uitkomst per criterium genoeg?

Het model geeft de aangeleverde feedback terug

Eduface zegt De feedback op Algemeen eindigt met: “Ik vindt de feedback wel sterk alleen mist MRA nog een beetje.” Dat is een zin in de eerste persoon over feedback, niet over het werk van de student.

De rubriek zegt Het criterium Algemeen gaat over taalgebruik, samenhang en verwijzingen.

In de praktijk Het bestand dat aan het model is aangeleverd bevatte het commentaar van de nakijker al.

Dit is een bevinding over het model: het neemt commentaar over dat al in het document staat. Wij leveren voor de testperiode de schone versie aan, en de vraag is of jullie willen dat het model bestaand commentaar juist wel meeneemt of juist negeert.

Antwoorden en aanvullingen

Gekozen voldaan of niet voldaan, per rubriekcriterium

Wat dat doet Het model spreekt per criterium alleen uit of eraan is voldaan. Het geeft geen kwaliteitsniveau en geen cijfer.

De beoordeling naast elkaar

Criterium	Gewicht	Nakijker	Eduface Uitkomst
Algemeen	12%	voldaan	voldaan • eens
Klinisch scenario (stap 1)	12%	voldaan	voldaan • eens
Klinische vraagstelling (stap 2)	12%	voldaan	voldaan • eens
Zoekstrategie (stap 3)	12%	voldaan	voldaan • eens
Kritische evaluatie van kwaliteit (stap 4)	12%	× niet voldaan	voldaan → model milder
Evidentietabel (stap 5)	12%	× niet voldaan	voldaan → model milder
Commentaar (stap 6)	12%	½ deels	voldaan → model milder
Conclusie (stap 7)	16%	voldaan	voldaan • eens

5 van 8

voldaan bij de nakijker

8 van 8

voldaan bij Eduface

5 van 8

criteria waarop ze het eens zijn

Wat de nakijker schreef

Hi [...], Je hebt een prima CAT geschreven met uitzondering op het methodologisch beoordelen van het hele artikel. Je had echt nog wat beter moeten omschrijven wat de goede en slechte kanten van het artikel waren en of je dus überhaupt iets kon met de berekening/bevinding.

Kritische evaluatie van kwaliteit en Evidentietabel zijn op beide onderdelen niet afgevinkt. Bij Commentaar is de helft van de onderdelen afgevinkt. Het eindoordeel is voldaan. Eindoordeel van de nakijker: voldaan. Eindoordeel van Eduface: voldaan.

Aantekeningen

Per criterium, letterlijk

1. Algemeen

Je deed goed werk met de duidelijke opbouw van patiëntsituatie naar klinische vraag, onderzoeksresultaten en conclusie. Maar taalfouten en een onrustige weergave van de zoekstrategie en tabellen maken het lastiger om je redenering te volgen. Corrigeer spelling en vaktermen, zoals 'symptomen' en 'magnetic resonance imaging', en maak de tabellen overzichtelijk en consistent.

2. Klinisch scenario (stap 1)

Je patiëntpresentatie is kort en duidelijk en leidt logisch naar de hypothese van lumbale radiculopathie. Maar de klinische redenering kan nog scherper. Koppel de belangrijkste bevindingen direct aan de hypothese en vervang 'spraken' door 'sprake' voor een professionelere formulering.

3. Klinische vraagstelling (stap 2)

Je hebt een duidelijke, meetbare klinische vraag opgesteld met alle belangrijke onderdelen en een onderbouwde prior-kans. Maar de afkorting voor de uitkomstmaat is niet overal hetzelfde. Gebruik consequent 'PVW' in de hele CAT, zodat je berekeningen en conclusies helder blijven.

4. Zoekstrategie (stap 3)

Je hebt de zoekstrategie en de koppeling tussen artikel, patiënt en inclusiecriteria duidelijk uitgewerkt. Maar de zoekactie is nog niet goed controleerbaar. Noteer de zoekdatum en database en controleer de zoekregistratie op vervormde termen, zodat iemand je aanpak kan herhalen.

5. Kritische evaluatie van kwaliteit (stap 4)

Je beoordeelt de methodologische kwaliteit zorgvuldig en benoemt zowel sterke punten als relevante beperkingen. Maar de gevolgen daarvan voor je conclusie blijven nog wat onduidelijk. Leg per belangrijkste beperking kort uit wat dit betekent voor de validiteit van het onderzoek en maak duidelijk onderscheid tussen een methodologisch probleem en beperkte toepasbaarheid in de eerstelijns.

6. Evidentietabel (stap 5)

Je hebt de diagnostische uitkomsten helder uitgewerkt en de berekeningen goed navolgbaar gemaakt. Maar de notatie van formules en afrondingen is nog niet overal gelijk. Noteer de berekeningen op dezelfde manier en kies één vaste afronding, zodat de uitkomsten intern consistent en eenvoudig te controleren zijn.

7. Commentaar (stap 6)

Je koppelt de onderzoekspopulatie goed aan de patiënt en gebruikt de PVW en NVW passend voor de klinische interpretatie. Maar de methodologische beperkingen mogen concreter. Licht toe hoe de onbekende testvolgorde en de twee niet-toegewezen deelnemers de betrouwbaarheid en toepasbaarheid voor deze patiënt beïnvloeden.

8. Conclusie (stap 7)

Je Bottom line beantwoordt de klinische vraag helder en koppelt de testuitslag goed aan de praktijk. Maar de concrete vervolgstap ontbreekt nog. Voeg toe wanneer je de patiënt herbeoordeelt en wanneer verwijzing of MRI nodig is bij aanhoudende verdenking.

De plekken met een verschil

Kritische evaluatie van kwaliteit (stap 4)

→ model milder

Nakijker	Beide onderdelen niet afgevinkt. Uit de eindfeedback: "Je had echt nog wat beter moeten omschrijven wat de goede en slechte kanten van het artikel waren en of je dus überhaupt iets kon met de berekening/bevinding."
Eduface	"Je beoordeelt de methodologische kwaliteit zorgvuldig en benoemt zowel sterke punten als relevante beperkingen." Het model vraagt daarna om de gevolgen voor de conclusie.
Rubriek	<i>De letterlijke rubriektekst van dit criterium is hier niet beschikbaar, dus deze regel blijft leeg.</i>

Het model noemt hier precies datgene voldoende wat in deze beoordeling niet is afgevinkt. Hier zag de nakijker iets dat het model niet noemt: wat was dat, zodat we het kunnen meenemen?

Evidentietabel (stap 5)

→ model milder

Nakijker	Beide onderdelen niet afgevinkt.
Eduface	"Je hebt de diagnostische uitkomsten helder uitgewerkt en de berekeningen goed navolgbaar gemaakt. Maar de notatie van formules en afrondingen is nog niet overal gelijk." Het model behandelt de notatie als een verbeterpunt binnen een voldoende.
Rubriek	<i>De letterlijke rubriektekst van dit criterium is hier niet beschikbaar, dus deze regel blijft leeg.</i>

Het model ziet de notatie van formules en afrondingen als een verbeterpunt en komt op voldaan. Waar ligt voor jullie de grens waarop dit onderdeel niet meer voldoet?

Commentaar (stap 6)

→ model milder

Nakijker	De helft van de onderdelen afgevinkt.
Eduface	"Je koppelt de onderzoekspopulatie goed aan de patiënt en gebruikt de PVW en NVW passend voor de klinische interpretatie. Maar de methodologische beperkingen mogen concreter." Het model geeft één uitkomst voor het hele criterium.
Rubriek	<i>De letterlijke rubriektekst van dit criterium is hier niet beschikbaar, dus deze regel blijft leeg.</i>

Het model geeft één uitkomst voor dit criterium en komt op voldaan. In deze beoordeling is de helft van de onderdelen afgevinkt: willen jullie die onderdelen apart beoordeeld zien?

Aantekeningen

Wat het model aanneemt, en wat jullie willen

Het model streept een gevonden punt weg tegen de rest

Eduface zegt Op drie criteria noemt het model een verbeterpunt en komt het toch op voldaan.

De rubriek zegt Het formulier kent per onderdeel twee standen en geen tussenstand.

In de praktijk Op diezelfde drie criteria is niet afgevinkt, terwijl het eindoordeel voldaan is.

Het model behandelt een gevonden verbeterpunt als groeifeedback binnen een voldoende. Willen jullie dat een gevonden punt op criteriumniveau zwaarder weegt, en zo ja op welke van de drie?

Het model en het eindoordeel staan los van elkaar

Eduface zegt Het model komt op alle acht criteria op voldaan en geeft als totaal voldaan.

De rubriek zegt Het eindoordeel is een eigen keuze op het formulier en geen optelsom van de criteria.

In de praktijk Drie criteria zijn niet of deels afgevinkt en het eindoordeel is voldaan.

In deze beoordeling leidt een niet afgevinkt criterium niet tot een onvoldoende eindoordeel. Willen jullie dat het model die twee lagen ook los houdt, of dat het bij het eindoordeel meeweegt?

Antwoorden en aanvullingen

